

CAPÍTULO 9.13

Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI)

PERFIL EUNACOM 1.07.2.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI)

Diagnóstico

- **Hemograma:** trombocitopenia **aislada** (GR y GB normales)
- **Biopsia de MO** solo si hay duda → megacariocitos ↑ (destrucción periférica)
- Señales de alarma que obligan a descartar leucemia: **fiebre + adenopatías + esplenomegalia**

PTI Aguda vs. Crónica

TABLA 9.13.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	PTI AGUDA	PTI CRÓNICA
Edad típica	Niños	Adultos
Antecedente	Infección viral previa	Enfermedad autoinmune (AR, LES)
Curso	Autolimitado (semanas)	Crónico, fluctuante
% que se cronifica	10–20% en niños	80–90% en adultos

Objetivo del tratamiento

Evitar **hemorragias graves**, no normalizar el recuento de plaquetas (con > 20.000–30.000 no suele haber sangrado grave).

Tratamiento PTI Aguda

TABLA 9.13.2: SITUACIÓN VS CONDUCTA	
SITUACIÓN	CONDUCTA
Plaquetas > 20–30k, solo petequias/equimosis	Observar (mayoría de los casos)
Plaquetas < 20–30k o paciente de riesgo	Corticoides orales
Hemorragia grave (digestiva, cerebral, urinaria)	IgG EV (primera línea) + corticoides EV ± transfusión de plaquetas

Tratamiento PTI Crónica

- **Corticoides vía oral** (siempre — no hay opción de observar)
- Si falla → segunda línea:

- - **Esplenectomía** (solo en crónica; 80% de éxito)
- - **Rituximab** (50% de éxito; no quirúrgico)
- Ambos → inmunosupresión → **vacunar contra neumococo** y vigilar infecciones

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 22 años sin antecedentes mórbidos consulta por petequias en extremidades inferiores y gingivorragia de 3 días de evolución. Examen físico normal, sin adenopatías ni esplenomegalia. Hemograma: Plaquetas 18.000/mm³, Hb 13.5 g/dL, Leucocitos 6.800/mm³. Frotis sanguíneo: trombocitopenia severa con plaquetas gigantes sin blastos ni esquistocitos."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Trombocitopenia Inmune Primaria (PTI): destrucción autoinmune periférica de plaquetas mediada por autoanticuerpos anti-glicoproteínas plaquetarias (GPIIb/IIIa). Es un diagnóstico de exclusión (trombocitopenia aislada con frotis normal y examen sin organomegalias). Indicación de tratamiento: Plaquetas < 20.000–30.000/mm³ o sangrado mucoso activo. Primera línea: Corticoides orales (Prednisona 1 mg/kg/d o Dexametasona 40 mg/d x 4d) o Inmunoglobulina EV (IgEV) si urgencia hemorrágica.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- PTI aguda: niños, post-infección viral, autolimitada. PTI crónica: adultos, 80–90% se cronifica
- Diagnóstico: trombocitopenia aislada en hemograma (GR y GB normales)
- Fiebre, adenopatías o esplenomegalia obligan a descartar leucemia
- Objetivo: evitar hemorragias, no normalizar plaquetas. Con plaquetas >20.000 es raro que sangren
- Hemorragias graves: IgG EV (lo más importante) + corticoides EV + eventual transfusión de plaquetas
- PTI aguda sin hemorragia grave: observar si plaquetas >20.000; corticoides si <20.000 o sangrado mucoso
- PTI crónica: siempre corticoides. Segunda línea: esplenectomía (80% éxito) o rituximab (50% éxito)
- Esplenectomía y rituximab producen inmunodepresión: vacunar contra neumococo

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE (PTI))

PREGUNTA 1

Niño de 6 años con petequias y equimosis de 1 semana de evolución, antecedente de cuadro viral hace 2 semanas. Hemograma: plaquetas $15.000/\text{mm}^3$, sin fiebre, sin adenopatías, sin esplenomegalia. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Observación y reposo
- B) Corticoides orales
- C) Inmunoglobulina G endovenosa
- D) Esplenectomía
- E) Biopsia de médula ósea

PREGUNTA 2

Paciente con sospecha de PTI que presenta púrpura, fiebre y esplenomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico que se debe descartar en primer lugar?

- A) Púrpura trombocitopénica trombótica
- B) Leucemia
- C) Púrpura de Schonlein-Henoch
- D) CID
- E) Enfermedad de von Willebrand

PREGUNTA 3

Mujer de 40 años con PTI crónica en tratamiento con corticoides, mantiene plaquetas entre $10.000\text{--}15.000/\text{mm}^3$ con sangrados frecuentes. ¿Cuál es el tratamiento de segunda línea más eficaz?

- A) Aumentar dosis de corticoides
- B) IgG endovenosa crónica
- C) Esplenectomía
- D) Transfusión de plaquetas periódica
- E) Hierro endovenoso

RESUMEN: PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE (PTI)

Esta clase cubre la púrpura trombocitopénica inmune (PTI) en sus formas aguda y crónica. La PTI aguda es más frecuente en niños, usualmente post-infección viral, autolimitada en pocas semanas, y solo 10-20% se cronifica. La PTI crónica es más frecuente en adultos (80-90% se cronifica), asociada a enfermedades autoinmunes previas. El diagnóstico se hace con hemograma que muestra trombocitopenia aislada (GR y GB normales). Si hay fiebre, adenopatías o esplenomegalia, se debe descartar leucemia. La biopsia de médula ósea solo se usa para descartar otras enfermedades. El objetivo terapéutico es evitar hemorragias, no normalizar las plaquetas. Con plaquetas >20.000 es raro que sangren. Las hemorragias graves se manejan con IgG endovenosa + corticoides EV + eventual transfusión de plaquetas. La PTI aguda sin hemorragias graves se observa o se dejan corticoides orales. La PTI crónica siempre lleva corticoides; segunda línea: esplenectomía (80% éxito) o rituximab (50% éxito).